[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
SARA CRISPIM FORTALEZA DE AQUINO(084.417.474-23);
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA(09.306.242/0001-82);

Vistos, etc.

RELATÓRIO

SARA CRISPIM FORTALEZA DE AQUINO ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de **ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA**, ambos qualificados nos autos eletrônicos.

A requerente afirma que é beneficiária do plano de saúde da ré, na categoria Saúde Plus, inscrita sob o nº 1468847058524.

Prossegue afirmando que portadora de doença crônica, mais especificamente a enfermidade denominada Diabetes *Melittus* tipo 1 (CID E10.9).

Para o tratamento da enfermidade se utiliza de múltiplas doses diárias de insulina administradas por canetas – insulinas Degludeca U100 e aplicações da insulina ultra-rápida, baseadas em contagem de carboidratos e correções.

Entretanto, afirma ainda que esse tratamento deixou de ser o mais adequado à sua saúde.

Dessa forma, sua assistente médica endocrinologista, Dra. Gizelle B. D. Bandeira (CRM-PB 6025/RQE-2896), prescreveu novo tratamento para substituir o anterior, a nova terapia consiste em uma bomba de infusão contínua de insulina, denominada Medtronic MINIMED 640g.

Ato contínuo, afirma que esse tratamento é composto por vários itens, listou-os:

a) Uma unidade do Sistema Minimed 640G, MMT-1752 (item permanente);
b) Uma unidade do aplicador Quick Set MMT-305QS (item permanente);
c) 12 caixas com 10 unidades do conjunto de infusão Quick Set (para um ano), MMT-399 (6mm cânula e 60cm catéter);
d) 12 caixas com 10 unidades do reservatório de insulina para bombas Medtronic MMT-332A (para um ano);
e) Uma unidade do transmissor Guardian Link 2 MMT-7730 (item de reposição anual);
f)12 caixas com cinco unidades de Sensores Enlite para glicemia em tempo real, MMT-7008-A (para um ano);

g) Uma unidade do Care Link USB Black para baixa de dados da bomba para computador – MMT-7306 (item permanente).

Desse modo, buscou saber o valor do tratamento, que foi orçado em R$ 57.770,00 (cinquenta e sete mil, setecentos e setenta reais).

Por não possuir condições financeiras de arcar com a referida terapia, buscou assistência do plano de saúde que é beneficiária para cobrir o tratamento prescrito pela assistente médica que lhe acompanha.

Daí obteve resposta negativa do plano de saúde, referente ao custeio/cobertura do tratamento médico solicitado.
Por essas razões, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Juntou documentos.

A antecipação dos efeitos da tutela foi denegada (id. 49069485).

Foi comunicada a interposição de agravo de instrumento pela requerente (id. 51776080).

Comunicação recebida do Egrégio Tribunal de Justiça concedendo o pedido liminar da agravante, consistente em obrigar o agravo em fornecer a medicação/tratamento conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 52031581).

Despacho deste Juízo determinando a intimação e cumprimento da medida concedida pela segunda instância (id. 52147808).

O mandado foi efetivamente recebido pela demandada (id. 52280264).

A ré apresentou manifestação informando o cumprimento da medida liminar (id. 52951407).

Devidamente citada (id. 51704300) a requerida apresentou contestação (id. 53320263), preliminarmente impugnando a justiça gratuita concedida à autora, no mérito afirmou que o tratamento requerido pela autora não está incluso no rol de procedimentos da ANS, e desse modo afirmou que a negativa do plano de saúde está em consonância com a legislação vigente, pugnando pela improcedência da demanda.

Por outro lado, alternativamente, suscitou que em caso de procedência da demanda, que seja autorizada a cobrança de coparticipação pelo tratamento custeado pelo plano, sendo 70% a cargo da entidade e 30% pela beneficiária.

A autora foi intimada para apresentar réplica (id. 53335744).

Foi anexado aos autos termo de entrega do equipamento e medicamento pela demandada (id. 53405727).

Réplica apresentada (id. 54515317).

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir (id. 55137074) oportunidade em que a autora pugnou pelo julgamento antecipado (id. 55514826), a demandada pugnou pela realização de perícia médica (id. 56134356).

O pleito de produção de prova pericial foi indeferido (id. 57199000).

É o relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Passo ao julgamento antecipado do mérito, visto que a causa se encontra madura para fins de julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória.

DAS PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Alega o requerido, em síntese, que o juízo não analisou a situação econômica do agravante na forma concreta, tendo em vista que ela é estudante do curso de medicina de faculdade particular de João Pessoa, pagando o valor de mensalidade de R$ 9.501,02.

Nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Lei 1060/50, considera-se necessitado para os fins da assistência judiciária gratuita, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Segundo o art. 4º do aludido diploma legal, para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação de pobreza, a qual, todavia, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Juiz exigir a comprovação da hipossuficiência para o deferimento ou não do pedido.

Tal alegação ventilada pelo demandado, não merece acolhimento.

Analisando a declaração de imposto de renda acostada pela autora (id. 48864097) percebo que ela aufere uma renda mensal de R$ 2.939,54 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativa à pensão por morte de seu pai.

Então, o simples fato de a mensalidade da graduação da autora ser no importe de R$ 9.501,02 não importa dizer que a mesma tenha rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Por outro lado, o fato de a requerente, estudante, residir em bairro nobre, não implica que a mesma tenha rendimentos suficientes para ter adquirido o imóvel ou que arque com as despesas de moradia de forma autônoma.

Conforme exposto pela demandante na exordial, em que pese o recebimento de pensão alimentícia, ficou evidenciado que a mesma é dependente financeira e reside com sua mãe, corroborado pelo termo de adesão ao plano de saúde como dependente (id. 53320276).

Pelas razões expostas, entendo que a ré não logrou êxito em afastar a presunção de hipossuficiência que goza a parte autora.

Afasto a preliminar aventada.

DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA

Ainda, antes de adentrar ao mérito, verifico que a parte autora em sua réplica afirmou suposto descumprimento da liminar pela requerida.

Afirmou que somente houve a entrega de 50% dos insumos prescritos pela médica assistente.

Analisando detidamente os autos, mais precisamente o termo de entrega juntado pela demandada (id. 53405727) existe a informação de que foi realizada a entrega parcial dos insumos requisitados pela assistente médica, sendo que as demais quantias do insumo seriam entregues à autora a cada dois meses.

A multa por descumprimento de medida liminar concedida judicialmente só é efetivamente aplicada quando comprovado o descumprimento.

Se uma decisão judicial impõe obrigação de fazer sob pena de pagamento de multa processual, a comprovação do seu respectivo descumprimento é requisito necessário para a imposição das astreintes.

Assim, não haverá incidência de astreintes quando não for comprovado o descumprimento da decisão judicial que as fixou.

Esse entendimento se coaduna com o princípio do *duty to mitigate the loss*, pelo qual deve a parte mitigar o seu próprio dano, não podendo se manter inerte, agravando, desnecessariamente, o seu prejuízo e elevando o patamar da multa processual, principalmente quando se sabe que o objetivo das astreintes é a satisfação da obrigação, que deve ser perseguida por ambas as partes no processo.

Por essas razões, deixo de aplicar multa por descumprimento da liminar, tendo em vista que não há comprovação nos autos da desobediência da ordem judicial.

DA APLICABILIDADE DO CDC NOS CONTRATOS DE SAÚDE SOB PATROCÍNIO DE ENTIDADES NA MODALIDADE AUTOGESTÃO

Inicialmente destaco a Súmula 608 do e. STJ que dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de **plano** de **saúde**, salvo os administrados por entidades de **autogestão**".

O CDC se aplica aos contratos de plano de saúde de autogestão quando comprovada a existência de abusividades com relação ao consumidor, pois o fato de pertencer a um grupo gestor pelos próprios beneficiários não descaracteriza a relação de consumidor e prestador de serviços.

A modalidade de autogestão restou comprovada nos autos.

Assentada tal premissa, tem-se que, com a devida vênia, a circunstância de a demandada consistir em pessoa jurídica desprovida de finalidade lucrativa não afasta a configuração da relação de consumo, ocorrendo esta apenas na hipótese em que o serviço ou produto prestado é gratuito, nos termos do § 2º do art. 3º do CDC.

O plano decorrente de autogestão possui como particularidade a sua não sujeição obrigatória ao plano-referência disposto no art. 10 e 12 da Lei 9.656/98.

Destaca-se que a jurisprudência se orienta no sentido de que a cobertura do seguro de saúde deve ser delimitada pelas enfermidades, não se podendo restringir os tratamentos a serem empregados.

Não se olvida a existência de precedente no STJ reconhecendo a inaplicabilidade do CDC para os planos de autogestão, mas este não consiste no entendimento predominante daquela Corte, conforme se destaca:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. SÚMULA Nº 284/STF. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 735/STF.
> (...).
> 2. O entendimento predominante no âmbito desta Corte é de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso, a cobertura médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos, quando administra plano de saúde remunerado a seus associados (STJ, AgRg no AREsp 813.590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016).
> Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, pois "a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços" (REsp n. 469.911/SP) (STJ, REsp 1392560/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 06/10/2016).

Portanto, aplica-se o CDC ao caso vertente.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, nota-se que a parte autora ajuizou a presente ação a fim de compelir a ré a custear/cobrir o fornecimento do equipamento e insumos para tratamento da sua patologia.

A doença crônica que afeta a autora, a diabetes mellitus tipo 1 (CID-10; E 10.9), está listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.

Portanto, as patologias listadas naquela lista têm cobertura obrigatória de tratamento, não existindo vedação legal quanto ao método de terapia indicado pelo profissional de saúde que acompanha o paciente.

A discussão nos autos é acerca do método indicado pela médica assistente da parte autora, onde a ré alega que o fornecimento do equipamento e insumo se classifica como de uso domiciliar.

Desse modo, o material não ligado a ato cirúrgico e medicamento para tratamento domiciliar são EXPRESSAMENTE excluídos da cobertura assistencial do plano de saúde, conforme consta no inc. VI do art. 10 da Lei 9.656/98, excetuado os de tratamento oncológico, que são obrigatórios.

A necessidade de utilização do método indicado pelo assistente médico está comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente, a prescrição médica (id. 48864090), bem como pelos relatórios médicos (id. 48864092), os quais comprovam que a requerente, 20 anos de idade, é portador de Diabetes Mellitus tipo 1, desde os 12 anos de idade, diagnosticada em 2013, apresentando oscilações na glicemia, ora com hiperglicemia e ora com hipoglicemia, fator este de agravamento das complicações com micro e macro vasculares de forma aguda que podem contribuir para acidentes automobilísticos.

Além disso, foi relatado no laudo que a paciente tem histórico de hipoglicemias frequentes abaixo de 54mg/dl e já apresentou quadro de convulsão devido hipoglicemia grave.

Vê-se, portanto, que a necessidade do uso da bomba de insulina não se trata de mero conforto para o paciente, sendo essencial à sua sobrevivência.

A insurgência do réu, é no sentido de que de que a bomba de insulina se enquadra como hipótese de tratamento domiciliar, não podendo ser exigida da operadora de plano de saúde. Afirma que o fornecimento de bomba de insulina não faz parte do rol taxativo da ANS.

Conforme se verifica dos autos (ID 48864499, ID 53320273 e ID 53320274) a recusa administrativa da demandada, referente ao fornecimento de bomba de insulina e insumos, embasou-se no Parecer Técnico 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, bem como no art. 10, inciso VI, VIII e XXI da Lei nº 9.656/98.

A referida recusa, entretanto, deve ser considerada à guisa do quadro clínico do recorrente, exposto por meio do relatório médico juntado aos autos.

Com efeito, o tratamento prescrito pela médica que acompanha a requerente – que expõe quadro de risco de morte e/ou convulsões por hipoglicemia grave e necessidade de utilização do equipamento – caracteriza-se como de urgência e emergência.

Nessa senda, e a despeito da resistência da operadora do plano de saúde, há que se reconhecer o direito de a autora obter da demandada o fornecimento da bomba de insulina e seus insumos, porquanto há nos autos elementos que demonstram a necessidade da realização do tratamento prescrito.

Ademais, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cobertura de contrato de plano de saúde é passível de limitação em razão das doenças, mas não em razão dos tratamentos a serem utilizados.

Desse modo, cabe ao médico assistente a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à condição do paciente, a fim de lhe garantir maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à operadora do plano de saúde ingerência nesse sentido.

Neste sentido:

> AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2º E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
> (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

E ainda:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito por médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
> (AgInt no REsp 1791639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

De início, esclareço que embora o STJ, ao julgar os EREsp 1886929 e EREsp 1889704, tenha decidido que o Rol da ANS é taxativo, no mesmo precedente, viabilizou a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos da lista, amoldável ao caso

concreto.

Nesta decisão foram definidas as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva *ad causam* da ANS.

Em outras manifestações, a citada Corte assentiu que, "conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.918.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Dessa forma, considerando-se que há previsão de cobertura dos custos relacionados ao tratamento da patologia da requerente, uma vez que seu quadro demanda tratamento com urgência, sob risco de morte declarado pela profissional médica que o acompanha, é abusiva a exclusão do fornecimento do tratamento indicado pelo médico especialista, configurando, portanto, o exercício irregular de um direito, pois além de não atender à finalidade do contrato revela-se incompatível com a boa-fé esperada.

Neste sentido, vem se posicionando o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba:

> APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. MÉDICO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO QUE JÁ CONSTOU DO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DO SEU CORRESPONDENTE NO BRASIL. DESPROVIMENTO.
> É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento médico que visa garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado.
> O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.

> (TJ-PB - AC: 08004125520218150231, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, entendo que se reputa abusiva a conduta praticada pelo plano de saúde, devendo então a promovida custear o tratamento indicado na exordial.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PREVISÃO DE COPARTICIPAÇÃO

Na hipótese, trata-se de plano de saúde mediante regime de coparticipação com o titular do plano, conforme observado pela requerida.

Somado a esse fato, de acordo com o regulamento do plano de saúde (id. 53320277) que prevê em seu art. 21 as modalidades de procedimentos inclusos no regime de coparticipação.

De acordo com o artigo 16, da Lei 9.658/98, tem-se que o regime de coparticipação nos planos de assistência médica, quando expressamente previsto em contrato, não é ilegal ou abusivo.

Todavia, observando o regulamento interno da entidade vejo que não há previsão para o caso da requerente, tampouco há menção de procedimento ou tratamento semelhante para a referida patologia.

Não obstante o regime de coparticipação seja válido conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de regra específica e clara aplicável ao tratamento prescrito à requerente.

Neste sentido:

> AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
> (...)
> NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA ACERCA DA COPARTICIPAÇÃO.
> (...)
> Por outro lado, também não merece prosperar a pretensão recursal no sentido da aplicação do regime de coparticipação, porquanto não demonstrada pela Cooperativa Médica a existência de previsão contratual específica;
> (...)
> Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 0176476-18.2018.8.06.0001/50000, acorda a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de janeiro de 2021. VERA LÚCIA CORREIA LIMA Desembargadora Relatora
> (TJ-CE - AGT: 01764761820188060001 CE 0176476-18.2018.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021) (trechos recortados do original).

A partir desse entendimento, tendo em vista que não há previsão contratual clara e específica para cobrança de coparticipação do procedimento aqui discutido, não cabe a imposição de pagamento à autora.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL para:** a) Determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente o fornecimento de todos os materiais e insumos mensais correspondente do "Sistema MINIMED 640G" em caráter definitivo, conforme prescrição médica;

Indefiro o pedido de pagamento de coparticipação pela autora do tratamento concedido neste processo, formulado pela ré, conforme fundamentação.

Condeno o promovido nas custas, e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

P.R.I.

Caso seja interposto recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

Onaldo Rocha de Queiroga
Juiz de Direito em Substituição

Assinado eletronicamente por: ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
12/12/2022 10:27:46
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 67029662

22121210274654200000006

IMPRIMIR GERAR PDF